BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU NẠO VA

Mã đề xuất CS-TMH-10; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: J35.2

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

*Khai thác tiền sử

- Đau họng mũi nhiểu hay, tính chất đau
- Nước bọt trong hay có máu, nếu có máu: tính chất , số lượng màu sắc
- Người bệnh có tiền sử dị ứng hay bệnh lý gì không
- Người bệnh có nghẹt mũi không
- Người bệnh, gia đình có được hướng dẫn cách chăm sóc sau mổ không
- Có dị ứng với thuốc gì không có bệnh lý kèm theo không.

*Khám

- Quan sát thể trạng.
- Quan sát da niêm.
- Quan sát tính chất màu sắc nước bọt
- Quan sát vị trí đau , tính chất đau

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1.Người bệnh đau do mới mổ

Nguy cơ chảy máu sau nạo VA; không quy nguyên nhân “cầm máu không kỹ” khi chưa xác định.

2.3. Người bệnh thiếu kiến thức, lo lắng về bệnh về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người

bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1. Giảm đau cho người bệnh

3.2.Giảm nguy cơ chảy máu

3.3 Giáo dục sức khỏe, giảm lo lắng cho người bệnh

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1. Giảm đau cho người bệnh

- Thực hiện thuốc giảm đau theo y lệnh, hướng dẫn người bệnh chườm lanh giảm đau

- Theo dõi tình trạng đau , tính chất đau, cường độ đau

- Động viên trấn an người bệnh

4.2.Giảm nguy cơ chảy máu

- Theo dõi dấu sinh hiệu chú ý mạch, huyết áp

- Theo dõi lượng nước bọt chảy ra có máu không số lượng màu sắc tính chất

- Hướng dẫn người bệnh nếu có ho nhiểu , nhảy mũi nhiểu phải báo cho nhân viên tế ngay,

Theo dõi nuốt liên tục, khạc/nôn máu, máu ở miệng/mũi và tình trạng hô hấp; không bắt trẻ tuyệt đối không nuốt nước bọt.

4.3 Giáo dục sức khỏe, giảm lo lắng cho người bệnh

* Tại phòng hậu phẫu

- Người bệnh nằm nghiêng một bên (hoặc nằm ngửa, đầu nghiêng sang một bên)

Khi chưa tỉnh hoàn toàn, tư thế hồi tỉnh/bảo vệ đường thở theo tình trạng và hướng dẫn gây mê; hút khi cần. Không để gạc/khăn rời trong miệng.

Máu đỏ tươi, chảy tiếp diễn, nôn máu hoặc nuốt liên tục cần báo bác sĩ ngay; không mặc định máu trong 3 giờ đầu là bình thường.

- Người nhà theo dõi thêm về vấn đề tiêu tiểu, có khó thở, buồn nôn, đau bụng, chóng mặt, lạnh run. Nếu có các dấu hiệu trên hoặc bất cứ bất thường nào khác, báo ngay nhận viên y tế.

* Tại phòng bệnh nội trú

Cho uống/ăn khi tỉnh đủ, bảo vệ đường thở và được phép theo kế hoạch sau mổ; bắt đầu lượng nhỏ, theo dõi dung nạp. Không quyết định chỉ dựa nước bọt trong một giờ hoặc mốc 4 giờ.

Nôn máu, phân đen, đau bụng, sốt hoặc dấu mất nước phải báo để đánh giá mức độ; không trấn an chung là thông thường sau mổ.

* Chế độ ăn những ngày sau mổ

Chế độ ăn theo chỉ định và dung nạp, bảo đảm nước và dinh dưỡng; không dùng lịch cứng cho mọi tuổi/can thiệp.

Chọn thức ăn/đồ uống phù hợp, tránh kích ứng và quá nóng; không bắt buộc uống nước đá.

Tăng dần ăn theo dung nạp và hướng dẫn; theo dõi chảy máu và mất nước.

5. Đánh giá

- Bệnh khỏe hơn , không xảy ra biến chứng, hết nghẹt mũi

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung "khỏe hơn" để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/adenoidectomy/. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……